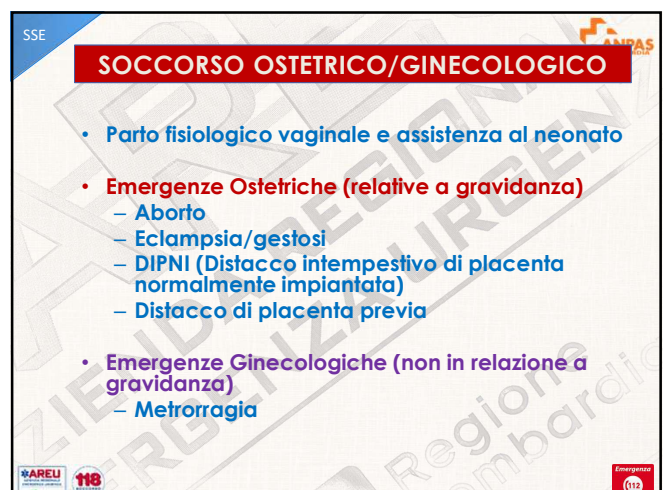
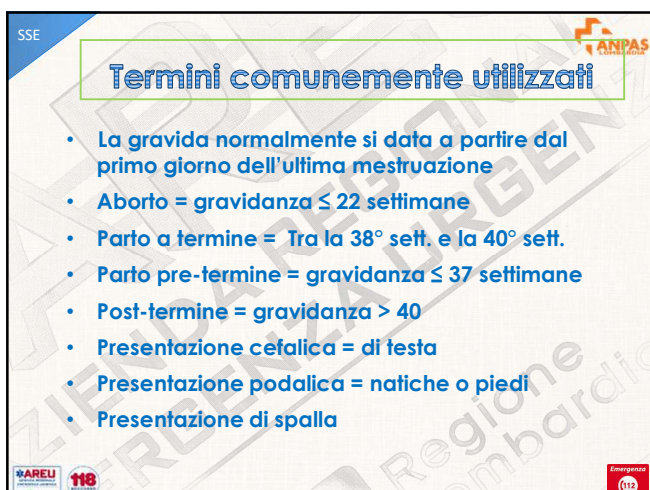
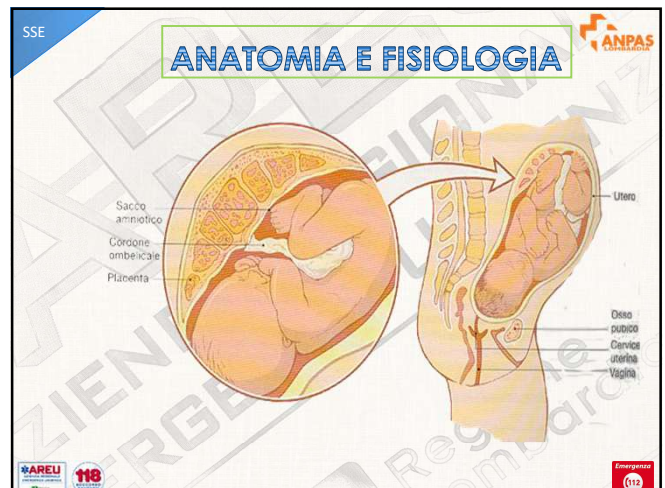
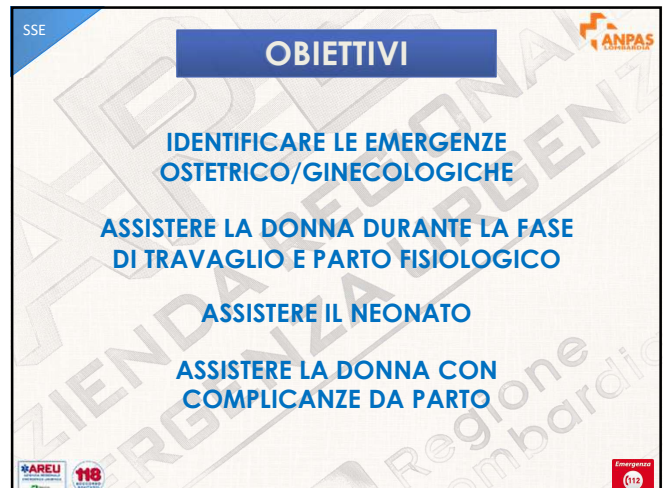




SSE

TRAVAGLIO E PARTO FISIOLÓGICO

1. **ABCDE**
2. **AMPIA**
3. **ANAMNESI OSTETRICA:**

VALUTARE

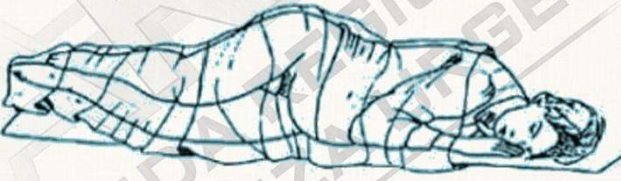
- Datazione della gravidanza
- Gravidanza singola o multipla
- Monitoraggio della gravidanza
- Numero di gravidanze e parti naturali e/o cesarei
- Frequenza e durata delle contrazioni
- Rottura del sacco amniotico («delle acque») e colore del liquido
- Emorragie
- Movimenti del feto (MAF)
- Presentazione del feto (ultima ecografia)

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

TRASPORTO DELLA DONNA GRAVIDA

DURANTE IL TRAVAGLIO



E' indicata la posizione in decubito laterale sinistro

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

FASI DEL PARTO FISIOLÓGICO

1° STADIO: DILATANTE

Primo stadio:
Dall'inizio delle contrazioni alla completa dilatazione della cervice



Contrazioni uterine presenti, non frequenti, di breve-media durata, possibile "rottura delle acque". la mamma è in grado di camminare. durata 8-12 h primigravida, 3-6 h secondigravida

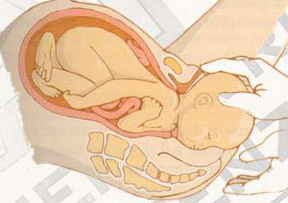
WAREU 118 Emergenza 112

SSE

FASI DEL PARTO FISIOLÓGICO

2° STADIO: ESPULSIVO

Secondo stadio:
Ingresso del feto nel canale del parto e susseguente fuoriuscita



Contrazioni più frequenti, regolari, desiderio irrefrenabile di spingere. Durata 1-2 h primigravida, entro 1h plurigravida. Fuoriesce il feto

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

ASSISTENZA ALLA FASE ESPULSIVA

2° STADIO: ESPULSIVO

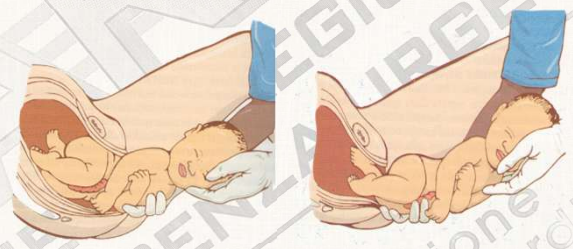


WAREU 118 Emergenza 112

SSE

ASSISTENZA ALLA FASE ESPULSIVA

2° STADIO: ESPULSIVO



WAREU 118 Emergenza 112

SSE

FASI DEL PARTO FISIOLÓGICO

3° STADIO: SECONDAMENTO

Terzo stadio:
Espulsione della placenta (secondamento)



Fase POST PARTUM
Fuoriuscita della placenta e degli annessi fetali.
Avviene generalmente entro un'ora dal parto.
Accompagnato da perdite ematiche (< a 500 ml)

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

Situazioni di Pericolo

IMPORTANTE EMORRAGIA (METRORRAGIA)
LIQUIDO AMNIOTICO «VERDOGNOLO»
PRESENTAZIONE PODALICA
PROLASSO DEL FUNICOLO CORDONE OMBELICALE CHE FUORIESCE
PARTO PRE-TERMINE ($\leq 37W$)
PARTO GEMELLARE
IPERTENSIONE ARTERIOSA
CONVULSIONI MATERNE

CONTATTARE TEMPESTIVAMENTE LA SOREU E SEGUIRE LE INDICAZIONI

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

ASSISTENZA AL PARTO IN POSTO

In presenza di:

- Bisogno irrefrenabile di spingere
- Distensione del perineo (si vede la testa del neonato)
- Perdite ematiche (rosso vivo)

SECONDO INDICAZIONE DELLA SOREU

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

ASSISTENZA AL PARTO FISIOLÓGICO

- AMBIENTE CALDO, POSSIBILMENTE TRANQUILLO
- MANI PULITE, GUANTI PULITI
- TELINI MONOUSO CALDI
- COPERTE E METALLINA
- GARZE STERILI, FISIOLÓGICA
- ASPIRATORE REGOLATO PER NEONATI (MAX 100 MMHG)
- SENSORE SATURIMETRO NEONATALE

SE DISPONIBILI 2 CLAMP MONOUSO PER CORDONE OMBELICALE

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

ASSISTENZA AL PARTO FISIOLÓGICO

MONITORARE COSTANTEMENTE I PARAMETRI VITALI DELLA MAMMA

SOSTENERE EMOTIVAMENTE LA MAMMA

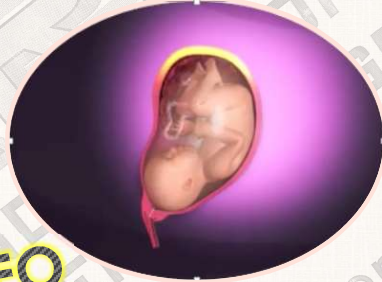
SEGUIRE INDICAZIONI DELLA SOREU:

- Invio msa/msi o trasporto immediato
- Posizione della madre e/o del neonato

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

FILMATO 3D PARTO FISIOLÓGICO



VIDEO

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ASSISTENZA AL NEONATO ANPAS

- SOSTENERE IL NEONATO, **SCIVOLA!**
- LIBERARE DELICATAMENTE IL CAVO ORALE DALLE SECREZIONI VISIBILI SE COIOSE O OSTRUTTIVE UTILIZZANDO ASPIRATORE
- ASCIUGARE IL NEONATO
- MANTENERE IL NEONATO CON UN PANNO CALDO E ASCIUTTO
- VALUTARE SECONDO LE INDICAZIONI SPECIFICHE

WAREU 118 Emergenza 112

SSE FILMATO ASSISTENZA ALLA NASCITA ANPAS

Assistenza alla nascita
Azioni iniziali

VIDEO

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ASSISTENZA AL NEONATO ANPAS

Valutare *in 30 secondi* dalla nascita

- TONO MUSCOLARE IN FLESSIONE
- PRESENZA RESPIRO
- PIANTO VALIDO

SEGNALI DI PERICOLO:

- TONO MUSCOLARE FLACCIDO
- PIANTO FLEBILE O ASSENTE
- APNEA/GASPING

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ASSISTENZA AL NEONATO ANPAS

SE IL NEONATO HA UN RESPIRO VALIDO, HA UN BUON TONO MUSCOLARE E UN PIANTO VIGOROSO:

- Seguire le indicazioni della SOREU per la gestione del cordone ombelicale

NON CLAMPARE, NON TAGLIARE

- Posizionare il neonato sul torace/addome della mamma, contatto pelle a pelle
- Coprire la mamma e il neonato con coperte

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ASSISTENZA AL SECONDAMENTO ANPAS

RACCOGLIERE E CONSERVARE LA PLACENTA E LE PERDITE EMATICHE IN UNA SACCHETTO DI PLASTICA PULITO E CONSEGNARE IN SALA PARTO



WAREU 118 Emergenza 112

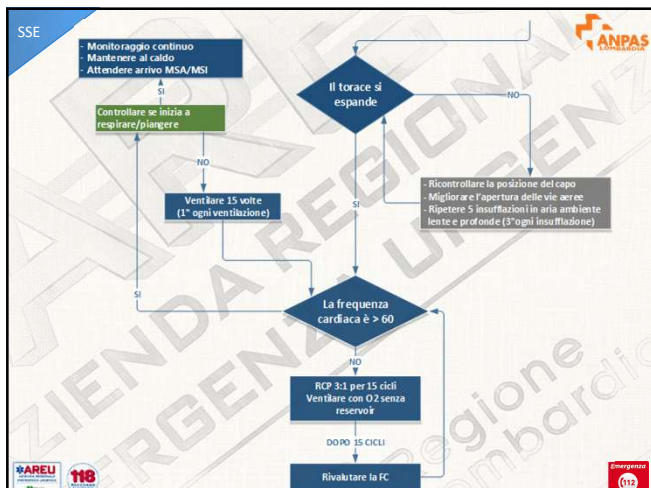
SSE FILMATO ASSISTENZA ALLA NASCITA ANPAS

SUPPORTO VENTILAZIONI



VIDEO

WAREU 118 Emergenza 112



CONCLUSIONI

COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE CON LA SOREU PER RIFERIRE L'ANAMNESI OSTETRICA E LE CONDIZIONI DEL NEONATO

PRESTARE MOLTA ATTENZIONE AL NEONATO APPENA DOPO IL PARTO

UNA BUONA ASSISTENZA ALLA MAMMA È LA MIGLIORE ASSISTENZA PER IL FETO E PER IL NEONATO



SSE

EMERGENZE OSTETRICHE

NEL PRIMO TRIMESTRE DELLA GRAVIDANZA

- Aborto
- Gravidanza extrauterina

NEL SECONDO/TERZO TRIMESTRE DELLA GRAVIDANZA

- Iperensione da eclampsia/gestosi
- Distacco intempestivo di placenta normalmente impiantata (DIPNI)
- Distacco di placenta previa

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

ABORTO

INTERRUZIONE PREMATURA DI UNA GRAVIDANZA (< 22 W)

Non è necessariamente un'emergenza, la madre può presentarsi in buone condizioni generali

Si manifesta con:

- Sanguinamento lieve/medio
- Dolore addominale

ASSISTENZA:

- Posizione supina o antalgica
- Panno pulito sui genitali

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

GRAVIDANZA EXTRA-UTERINA

Impianto dell'embrione fuori dalla cavità uterina

È UN'EMERGENZA

Si manifesta con:

- Dolore addominale a "lama di pugnale"
- Ipotensione/ipotimia
- Segni di shock emorragico
- Rapido peggioramento dei parametri vitali

ASSISTENZA:

- Monitorare costantemente ABC e parametri vitali
- Somministrare O2
- Posizionare in antishock

SEGUIRE INDICAZIONI della SOREU

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

GESTOSI (PRE-ECLAMPSIA)

Sindrome clinica che può comparire nella seconda metà della gravidanza caratterizzata dalla presenza di edema e/o proteinuria e/o ipertensione arteriosa.

PUÒ PORTARE ALL'ECLAMPSIA

SEGUIRE INDICAZIONI della SOREU

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

ECLAMPSIA

Grave patologia della gravidanza caratterizzata da convulsioni; è una sindrome complessa nella quale l'evento acuto rappresenta l'emergenza.

Si manifesta con:

- Iperensione
- Cefalea e disturbi visivi
- Dolore addominale "a barra"
- Crisi convulsive importanti
- Possibile evoluzione in morte materna e/o fetale

SEGUIRE INDICAZIONI della SOREU

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

ECLAMPSIA

DURANTE LA CRISI CONVULSIVA:

- Assistere la persona, allontanare oggetti per evitare traumi secondari
- Non cercare di immobilizzare il paziente
- Allentare gli abiti
- Non mettere nulla in bocca, attenzione ai morsi

DURANTE LA FASE POST-CRITICA:

- Somministrare ossigeno
- Posizione fianco sinistro
- Monitorare segni vitali

SEGUIRE INDICAZIONI della SOREU

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

DISTACCO INTEMPESTIVO DI PLACENTA

Normalmente Impiantata (DIPNI)

La placenta si distacca dall'inserzione uterina prima dell'espulsione del feto

E' UN'EMERGENZA

Si manifesta con:

- Dolore addominale intenso e improvviso
- Contrazione costante dell'utero
- Emorragia da assente ad abbondante
- Segni di shock

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

DISTACCO INTEMPESTIVO DI PLACENTA

Placenta previa: impianto in sede anomala della placenta
(nel terzo inferiore della cavità uterina)

E' UN'EMERGENZA
ANCHE SE LA PAZIENTE È TRANQUILLA

Si manifesta con:

- Emorragia medio/abbondante
- Assenza di dolore
- Rapido peggioramento dei parametri vitali

WAREU 118 Emergenza 112

SSE

EMERGENZE GINECOLOGICHE

METRRORRAGIA

Perdita di sangue uterino che si manifesta al di fuori dei periodi mestruali senza regolarità

Le cause variano a seconda dell'età della donna

Si manifesta con:

- Dolore addominale
- Emorragia lieve/media
- Condizioni generali non deteriorate

ASSISTENZA:

- Posizione supina o antalgica
- Monitoraggio costante ABC e Parametri Vitali

SEGUIRE INDICAZIONI della SOREU

WAREU 118 Emergenza 112

SSE



WAREU 118 Emergenza 112

SSE

Conclusioni

NELLE DONNE IN ETÀ FERTILE CON DOLORE ADDOMINALE CONSIDERARE SEMPRE LA POSSIBILITÀ DI UNA GRAVIDANZA

LE EMERGENZE OSTETRICHE SONO RARE MA NECESSITANO DI UN PRONTO RICONOSCIMENTO E ASSISTENZA

WAREU 118 Emergenza 112